2.治疗同 DKA，但：

①24 小时补液量可达 6000-10000ml，休克患者应另予血浆或全血（维持血容量）脱水程度比DKA严重，补液量更多

②**在输入生理盐水后，若无休克、血浆渗透压＞350、血钠＞155 才可输入低渗液**（低渗液会导致RBC吸水破裂发生溶血）

③先用 NS+小剂量 RI（0.05-0.1U/kg·h），当血糖降至 **16.7** 改用 5%葡萄糖+胰岛素（哈哈上岸要录取我）

④多不补 $NaHCO_3$（对胰岛素更敏感，剂量更小）

⑤连续性肾脏替代治疗 CRRT 有利于减少严重 HHS 患者发生多器官功能障碍综合征（MODS）的风险

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

（三）糖尿病肾病 欧美慢性肾衰竭最常见原因

1.易发展为慢性肾衰竭：弥漫性肾小球硬化最常见、对肾功能影响最大（弥漫），但结节性肾小球硬化 **K-W 结节最有特征**（gentleman）

2.分期

DKD 临床上以持续性蛋白尿和/或肾小球滤过率进行性下降为主要特征。目前参照慢性肾脏病（chronic kidney disease，CKD）的分期及评估指标，采用估算的肾小球滤过率（eGFR）与尿白蛋白/肌酐比值（UACR）联合评估方法（GA 分期法）对 DKD 进行临床分期，其中 G 代表 eGFR 水平，分为 G1～5；A 代表白蛋白尿水平，分为 A1～3。根据 GA 分期评估 DKD 的严重程度、预测预后、指导制订治疗和随访策略（表 7-8-1）。

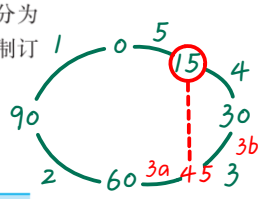


表 7-8-1　CKD 按 eGFR 和 UACR 分期及其进展风险

CKD 分期	肾脏损害程度（eGFR 水平）	GFR 分级/[ml/（min·1.73m²）]	白蛋白尿分期 A1（UACR<30mg/g）	A2（UACR 30～<300mg/g）	A3（UACR≥300mg/g）
G1	正常	≥90	低风险	中风险	高风险
G2	轻度下降	60～89	低风险	中风险	高风险
G3a	轻中度下降	45～59	中风险	高风险	极高风险
G3b	中重度下降	30～44	高风险	极高风险	极高风险
G4	重度下降	15～29	极高风险	极高风险	极高风险
G5	肾衰竭	<15	极高风险	极高风险	极高风险

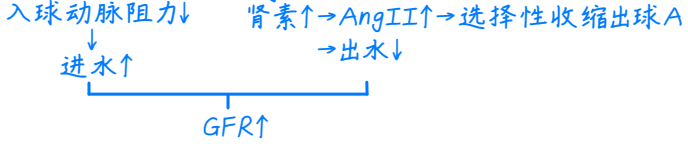
横看：12 低中高

竖看：依次递增

9 版教材分期：中老年继发肾病综合征：遂宁糖粉

	I（初期）	II（临床前期）	III（早期肾病期）	IV（临床肾病期）	V（尿毒症期）
GFR	↑↑	↑	正常或↑	↓	↓↓
UAER（尿白蛋白排泄率）	正常	间歇性↑	持续 20-200μg/min	＞200	↓
尿蛋白	-	运动后可+	微量白蛋白尿（重要）30-300mg/d	＞500，可伴高血压、肾病综合征	尿毒症

早期：血糖↑→尿糖↑→近端小管重吸收糖↑→重吸收钠↑（同向转运）→流经远曲小管致密斑的钠↓



3.治疗

①用**胰岛素**控制血糖（①高血压一线药物②增敏胰岛素 ③减少尿蛋白排泄，保护肾脏）

②首选 **ACEI/ARB** 降血压＜**130/80**mmHg（小三八）

③不用糖皮质激素（升血糖）